

HESTAZINE

Film Coated Tablets & Syrup



Composition:

Tablets: Each HESTAZINE Film Coated Tablet contains:

Cetirizine Hydrochloride 10 mg.

Syrup: Each 5 ml HESTAZINE Syrup contains:

Cetirizine Hydrochloride 5 mg.

Pharmacological Properties:

Cetirizine, a human metabolite of hydroxyzine, is a potent antihistamine, selective H1 receptors antagonist. The histamine-mediated «early» phase of the allergic reaction is inhibited by cetirizine, which also reduces the migration of inflammatory cells and the release of mediators associated with the «late» allergic responses. Cetirizine is unlikely to cause undesirable anti-cholinergic and anti-serotonin effects.

Pharmacokinetics:

Cetirizine is rapidly absorbed from the gastrointestinal tract with a time to maximum concentration (T_{max}) of about 1 hour after oral administration of tablets or syrup formulation in adult volunteers. Bioavailability was found to be similar between the tablet and syrup dosage forms. Plasma protein binding of cetirizine is 93 ± 0.3%. Cetirizine does not undergo extensive first pass metabolism. The terminal half-life is approximately 10 hours. About two thirds of the dose are excreted unchanged in urine.

Indications:

In adults and children aged 2 years and above:

- HESTAZINE is indicated for the relief of nasal and ocular symptoms of seasonal and perennial allergic rhinitis.

- HESTAZINE is indicated for the relief of symptoms of chronic idiopathic urticaria.

Contraindications:

- In patients who are hypersensitive to cetirizine, to any components of the product, to hydroxyzine or to any piperazine derivatives.

- In patients with severe renal impairment at less than 30 ml/min creatinine clearance.

Warnings & Precautions:

- Caution should be taken in patients with predisposition factors of urinary retention (e.g. spinal cord lesion, prostatic hyperplasia) as cetirizine may increase the risk of urinary retention.

- Caution in epileptic patients and patients at risk of convulsions are recommended.

- Allergy skin tests are inhibited by antihistamines and a wash-out period (of 3 days) is required before doing this test when taking the drug.

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: Cetirizine may be used for pregnant women, but caution should be exercised.

Lactation: Cetirizine is excreted in mother milk at concentrations representing (25- 90)% of those measured in plasma depending on sampling time after administration. Caution therefore should be exercised when prescribing cetirizine to lactating women.

Driving & Using Machines:

Do not exceed the recommended dose in patients who intend to drive, operate machinery or perform precise activities. The simultaneous use of CNS inhibitors may result in additional decrease in vigilance and poor performance.

Side Effects:

Clinical studies have shown that cetirizine at the recommended dosage has minor adverse effects on the CNS, including somnolence, fatigue, dizziness and headache. In some cases, paradoxical CNS stimulation.

Rare cases of micturition difficulty, eye disorders and dry mouth have been reported.

Instances of abnormal hepatic function with elevated hepatic

enzymes accompanied by elevated bilirubin have been reported. Mostly these symptoms go away when treatment is stopped. The following adverse effects were reported for cetirizine 10 mg in clinical trials at rates of 1% or greater: Fatigue, dizziness, headache, abdominal pain, dry mouth, nausea, somnolence, and pharyngitis.

Adverse effects that occurred in children aged 6 months to 12 years, at a rate of 1% or more: diarrhoea, drowsiness, rhinitis, fatigue.

Drug Interactions:

Concomitant use of cetirizine with other CNS depressants should be avoided as reduction in alertness and impairment of performance may occur.

Dosage & Administration:

Adults and children 12 years of age and over: 10 mg daily (10 ml of syrup or one tablet daily).

Children 6-11 years old: 10 mg daily (5 ml syrup twice or 10 ml once daily).

Children aged 2-5 years: 5 mg daily (5 ml syrup once daily or 2.5 ml twice daily).

At present there is insufficient clinical data to recommend the use of Cetirizine in children under 2 years of age.

Patients with moderate to severe renal impairment: Since cetirizine is mainly eliminated via renal route, in cases no alternative treatment can be used, the dosing intervals must be individualized according to renal function as follows:

Group	Creatinine clearance (ml/min)	Dosage and Frequency
Normal	≥80	10 mg once daily
Mild	50 - 79	10 mg once daily
Moderate	30 - 49	5 mg once daily
Severe	< 30	5 mg once every 2 days
End-stage renal disease-Patients undergoing dialysis	< 10	Contraindicated

In pediatric patients suffering from renal impairment, the dose will have to be adjusted on an individual basis taking into account the renal clearance of the patient, age and body weight.

Patients with hepatic impairment: No dose adjustment is needed in patients with solely hepatic impairment.

Overdose:

Symptoms: Side effects reported after an intake of at least 5 times the recommended daily dose are: Confusion, diarrhoea, dizziness, fatigue, headache, malaise, mydriasis, pruritus, restlessness, sedation, somnolence, stupor, tachycardia, tremor, and urinary retention.

Treatment: There is no known specific antidote to cetirizine. Should overdose occur symptomatic or supportive treatment is recommended.

Storage:

Keep out of reach of children. Store below 30 °C.

Packaging:

Tablets: Each HESTAZINE carton box contains 10 Film Coated Tablets in a blister strip.

Syrup: Each HESTAZINE Syrup carton box contains amber glass bottle of 100 ml.

*A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
- The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- KEEP THE MEDICATIONS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministries, Union of Arab Pharmacies



هيستانين

مضغوظات ملبسة بالفيلم & شراب

التركيب:

المضغوظات: كل مضغوظة هيستانين ملبسة بالفيلم تحتوي على:

سيتريزين هيدروكلوريد ١٠ ملغ.

الشراب: كل ٥ مل هيستانين شراب تحتوي على:

سيتريزين هيدروكلوريد ٥ ملغ.

الخصائص الدوائية:

السيتريزين مستقلب بشري للهيدروكسيدين وهو مضاد هستاميني فعال، وحاصر انتقائي لمستقبلات H_1 . يثبط السيتريزين المرحلة «المبكرة» لرد الفعل التحسسي المتواسطة بالهستامين، والذي يخفف أيضاً هجرة الخلايا الالتهابية وتحرير الوسائط المرتبطة بالاستجابات التحسسية «المتأخرة». وبالتالي من غير المحتمل أن يسبب السيتريزين تأثيرات غير مرغوبة مضادة للفعل الكوليني ومضادة للسيروتونين.

الحركة الدوائية:

يتم امتصاص السيتريزين بسرعة من القناة الهضمية ويصل إلى التركيز الأقصى (T_{max}) خلال ساعة واحدة بعد تناول المضغوظات أو الشراب عن طريق الفم لدى المتطوعين البالغين. وجد أن التوافر الحيوي متشابه بين أشكال الجرعات المضغوظات والشراب. تبلغ نسبة ارتباط السيتريزين ببروتين البلازما $93 \pm 0.7\%$ ، لا يخضع السيتريزين لعملية استقلاب أولية واسعة النطاق. يبلغ العمر النصفاني النهائي حوالي ١٠ ساعات. يطرح حوالي ثلثي الجرعة في البول دون تغيير.

الاستقطابيات:

عند البالغين والأطفال بعمر سنتين وما فوق:

- يستطبع هيستانين للتخفيف من الأعراض الأنفية والعينية المرافقة لالتهاب الأنف التحسسي الموسمي والدائم.

- يستطبع هيستانين لتخفيف من أعراض الشرى المزمن مجهول السبب.

مضادات الاستقطاب:

- عند المرضى الذين لديهم فرط حساسية للسيتريزين، أو تجاه أي من مكونات المستحضر أو للهيدروكسيدين أو تجاه أي من مشتقات البيبيرازين.

- عند المرضى الذين يعانون من قصور كلوي شديد بتصفية كرياتينين أقل من ٣٠ مل / دقيقة.

التحذيرات والاحتياطات:

- يجب أخذ الحذر عند المرضى الذين لديهم عوامل مهيبة لاحتباس البول (مثل آفة في الحبل الشوكي، تضخم البروستات) لأن السيتريزين قد يزيد من خطر احتباس البول.

- ينصح بأخذ الحذر عند مرضى الصرع والمرضى المعرضين لخطر الاختلاجات.

- تثبط مضادات الهستامين اختبارات الحساسية الجلدية ويجب ترك فترة انتقاع لمدة (٣ أيام) قبل القيام بهذا الاختبار عند تناول الدواء.

الحمل والإرضاع:

الحمل: يمكن استخدام سيتريزين عند النساء الحوامل، لكن يجب توخي الحذر.

البحر: يفرز السيتريزين في حليب الأم بتركيزات تمثل (٢٥ - ٩٠) % من تلك المقاسة في البلازما، اعتماداً على وقت أخذ العينات بعد تناوله. ولذلك يجب توخي الحذر عند وصف السيتريزين للمرضعات.

القيادة واستخدام الآلات:

يجب عدم تجاوز الجرعة الموصى بها لدى المرضى الذين يعتزمون القيادة أو تشغيل الآلات أو القيام بأنشطة دقيقة. كما أن الاستخدام المتزامن مع مثبطات الجهاز العصبي المركزي قد يسبب انخفاضاً إضافياً في اليقظة وضعفاً في الأداء.

التأثيرات الجانبية:

أظهرت الدراسات السريرية أن السيتريزين في الجرعة الموصى بها له آثار جانبية خفيفة على الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك النعاس، التعب، الدوخة والصداع. في بعض الحالات، تحفيز متناقض للجهاز العصبي المركزي. تم تسجيل حالات نادرة لصعوبة التبول، اضطرابات في العين وجفاف الفم.

تم تسجيل حالات من شذوذ الوظيفة الكبدية مع ارتفاع الإنزيمات الكبدية مترافقة بارتفاع البيليروبين. غالباً تزول هذه الأعراض عند التوقف عن العلاج.

تم الإبلاغ عن التأثيرات السلبية التالية للسيتريزين ١٠ ملغ في التجارب السريرية بنسبة ١ % أو أكثر: تعب، دوخة، صداع، ألم في البطن، جفاف الفم، غثيان، نعاس والتعب البليوم.

التأثيرات السلبية التي ظهرت عند الأطفال بعمر ٦ أشهر إلى ١٢ سنة بنسبة ١ % أو أكثر: إسهال، نعاس، التهاب الأنف، تعب.

التداخلات الدوائية:

يجب تجنب الاستخدام المتزامن للسيتريزين مع مثبطات الجهاز العصبي المركزي الأخرى حيث قد يحدث انخفاض اليقظة وضعف الأداء.

الجرعة والاستعمال:

البالغون والأطفال بعمر ١٢ سنة وما فوق: ١٠ ملغ يومياً (١٠ مل من الشراب أو مضغوظة واحدة يومياً).

الأطفال بعمر ١١-٦ سنة: ١٠ ملغ يومياً (٥ مل من الشراب مرتين أو ١٠ مل مرة واحدة يومياً).

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٥-٢ سنوات: ٥ ملغ يومياً (٥ مل من الشراب مرة واحدة يومياً أو ٢,٥ مل مرتين يومياً).

في الوقت الحالي، لا توجد بيانات سريرية كافية للتوصية باستخدام سيتريزين عند الأطفال دون سن الثانية.

المرضى المصابون بقصور كلوي متوسط إلى شديد: بما أن السيتريزين يطرح بشكل رئيسي بالطريق الكلوي، في حال عدم القدرة على استخدام علاج جديد، يجب أن يتم اختيار فترات الجرعات بشكل فردي وفقاً للوظيفة الكلوية كما يلي:

المجموعة	تصفية الكرياتينين (مل/دقيقة)	الجرعة والتكرار
طبيعي	$80 \leq$	١٠ ملغ مرة واحدة يومياً
خفيف	٥٠-٧٩	١٠ ملغ مرة واحدة يومياً
متوسط	٣٠-٤٩	٥ ملغ مرة واحدة يومياً
شديد	٣٠	٥ ملغ مرة واحدة كل يومين
المرحلة الأخيرة للمرض الكلوي - المرضى الذين يخضعون للغسيل الكلوي	١٠	مضاد استقطاب

يجب تعديل الجرعة عند المرضى الأطفال الذين يعانون من قصور كلوي، يجب تعديل الجرعة على أساس فردي مع مراعاة التصفية الكلوية للمريض والعمر ووزن الجسم.

المرضى الذين يعانون من قصور كلوي: ليس هناك حاجة إلى تعديل الجرعة عند المرضى الذين يعانون من قصور كلوي وحده.

فرط الجرعة:

الأعراض: الآثار الجانبية المبلغ عنها بعد تناول ما لا يقل عن ٥ أضعاف الجرعة اليومية الموصى بها هي: الارتباك، الإسهال، الدوخة، التعب، الصداع، الغثيق، توسع حقة العين، الحكة، الأرق، التخدير، النعاس، الذهول، تسرع ضربات القلب، والغثاس، واحتباس البول.

العلاج: لا يوجد ترياق محدد معروف للسيتريزين. في حال حدوث جرعة زائدة يوصى بالعلاج العرضي أو الداعم.

الاحتذات:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ °م.

التعليق:

المضغوظات: كل عبوة كرتونية هيستانين تحتوي على ١٠ مضغوظات ملبسة بالفيلم ضمن شريط بليستر.

الشراب: كل عبوة كرتونية هيستانين شراب تحتوي على عبوة زجاجية عاتمة سعة ١٠٠ مل.

الدواء مستحضر على شكل مضغوظات وأدوية خافضة للحموضة خلال الحملات بمرحلة التطوير. يجب وصف الدواء بوضوح وفقاً للإرشادات الموصى بها. في حالة حدوث جرعة زائدة، يجب وصف الدواء بوضوح وفقاً للإرشادات الموصى بها. في حالة حدوث جرعة زائدة، يجب وصف الدواء بوضوح وفقاً للإرشادات الموصى بها. في حالة حدوث جرعة زائدة، يجب وصف الدواء بوضوح وفقاً للإرشادات الموصى بها.

إنتاج شركة ريفال للصناعات الدوائية - سوريا